



República de Guinea Ecuatorial



Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial

Facultad de Ciencias de la Salud

Departamento de Investigación y postgrado

Asignatura: *TRABAJO FIN DE GRADO*
4º GRADO EN ENFERMERÍA 7º SEMESTRE 2024-2025

TÍTULO DEL TFG

**INCIDENCIA DE OTITIS EXTERNA DIFUSA AGUDA. SERVICIO
DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO BATA.
ENERO-MARZO 2024**

EJERCICIO EVALUATIVO N° 5

TEMA DEL EJERCICIO EVALUATIVO

Tema 5: El Marco Teórico

Autor/a:

**Nathan Ramón MICHA
EDJANG OKOMO**

Profesor:

MSc. Bonifacio Obama

Bata, 2024

EJERCICIO EVALUATIVO 5

Tema: El Marco Teórico

Considerando lo visto y explicado en la conferencia 5, realiza y responde:

1. Introducción del tema Marco Teórico de una investigación científica, máximo 3 páginas, mínimo 2 páginas, usando bibliografías de los años 2022-2023, máximo 3 autores, mínimo 2 autores. **3 ptos**
2. Elabora la construcción del marco teórico del tema de su informe de investigación o TFG. **1 ptos**
3. Realizar el marco teórico de su tema de informe de investigación. Máximo 5 páginas, mínimo 4 páginas. Las bibliografías de los años 2020-2024. **4 ptos**
4. Elaborar las referencias bibliográficas de las bibliografías revisadas. En las preguntas 1 y 3. **2 ptos.**

RESPUESTAS DEL EJERCICIO EVALUATIVO 5

- 1. Introducción del tema Marco Teórico de una investigación científica, máximo 3 páginas, mínimo 2 páginas, usando bibliografías de los años 2022-2023, máximo 3 autores, mínimo 2 autores.**

INTRODUCCIÓN

El marco teórico es una parte fundamental de cualquier trabajo de investigación, ya que proporciona el contexto y la base conceptual sobre la cual se desarrolla el estudio. Se define como la recopilación de antecedentes teorías y conceptos relevantes que sustentan el problema de investigación que se está abordando. **Según Dra. Sonia Anckermann y Dra. Sindy Cheesman (Universidad de San Carlos de Guatemala).** Es una de las partes de la investigación que permite describir, comprender, explicar e interpretar el problema desde un plano teórico, así como el planteamiento de las hipótesis que contienen una respuesta al problema de estudio. Amplia la descripción y análisis del problema, orienta hacia la organización de datos o hechos significativos para descubrir las relaciones de un problema con las teorías ya existentes e integra la teoría con la investigación. El marco teórico de una investigación es la parte de la investigación en la que se expone el sustento teórico. Se trata de un conjunto de ideas que marcan el curso del trabajo que se lleva a cabo y lo ponen en relación con otras investigaciones ya realizadas. ¹

Según Arias (2023). El marco teórico es el producto de la revisión documental-bibliográfica y consiste en una recopilación de autores conceptos y definiciones, que sirven de base a la investigación por realizar, los cuales comprenden los antecedentes de investigación, bases teóricas y sistema de variables. Seguidamente se desarrollan los soportes teóricos que dan sustentos al estudio y que permiten la Operacionalización de las variables en cuestión. ²

Las teorías describen fenómenos a través de una serie de reglas, de correspondencias que establecen las relaciones entre los mismos. En un nivel superior los paradigmas o conjunto de teorías, axiomas, normas, prejuicios, metodologías y prácticas que conforman una cultura científica. Mientras la teoría se define como la explicación especulativa de la realidad (en nuestro caso es educación) e incluye un conjunto de leyes y sistemas explicativos de esa realidad. La práctica, por el contrario, es fundamentalmente la experiencia que permite la transformación de esa realidad educativa. ²

Los antecedentes son las investigaciones previas que se asemejan a la que se está llevando a cabo. De acuerdo con algunas escuelas, el mínimo de antecedentes a presentar es tres. Se requiere que estas investigaciones sean de los últimos cinco años, para asegurar que los datos presentados en ellas estén vigentes aún.

Al presentar los antecedentes de la investigación, se deben incluir los siguientes aspectos: 1. Título, problema y objetivos de la investigación; 2. Metodología empleada; 3. Conclusiones; 4. Relación entre esta investigación y la que se está llevando a cabo. ²

La función general del marco teórico es acondicionar la información científica que existe sobre lo que se va a investigar, para tener conocimiento científico nuevo, ya que nos sirve para: no cometer errores en nuestro estudio a desarrollar o a prevenirlos de ser posible, nos da guías de cómo hacer nuestro estudio.

Funciones del marco teórico: 1. **Contextualización** (ayuda a situar el tema de investigación dentro de un marco más amplio, permitiendo entender cómo se relaciona con estudios previos y teorías existentes); 2. **Fundamentación** (proporciona las bases teóricas necesarias para el análisis del tema, lo que permite justificar la elección del enfoque y las metodologías utilizadas); 3. **Orientación** (sirve como guía para el desarrollo del estudio, ayuda a definir los conceptos claves y las variables que se van a investigar. El marco teórico supone una identificación de fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se podrá investigar y diseñar la investigación propuesta. La lectura de textos, libros especializados, revistas, y trabajos anteriores en la modalidad de tesis de grado son fundamentales en su formulación. ²

Otras funciones:

- Sustentar debidamente el problema en un cuerpo de conocimientos.
- Describir los antecedentes teóricos, los estudios o ensayos que permiten fundamentar la investigación propuesta.
- Reconsiderar el programa de investigación comparando el diseño de la prueba, decisiones y conclusiones con los de investigaciones ya publicadas.

La definición de términos básicos es un glosario de los conceptos principales involucrados en las variables de investigación. Los términos básicos que se definen deben ser los que a juicio del investigador posibilitará a que otros investigadores puedan conocer términos nuevos en la especialidad.

Tipos de definiciones:

- **Etimológica.** Origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación.
- **Funcionales.** La forma de cómo se va a desarrollar la solución.
- **Según autor.** Consiste en la determinación de la esencia de algo (explicación de lo que es la cosa).

El objetivo del marco teórico es proporcionar un contexto sólido y fundamento para la investigación que se está llevando a cabo. Entre los principales objetivos tenemos: 1. **Fundamentar la investigación** (el marco teórico busca establecer las bases teóricas que sustentan al estudio, permitiendo al investigador conocer y documentar las voces de autoridad en el tema); 2. **Acondicionar la información** (su función es organizar y presentar la información científica existente sobre el tema de investigación); 3. **Definir objetivos y tareas** (el marco teórico establece claramente los objetivos del proyecto y define las tareas de investigación necesarias. Esto incluye la expresión de la esencia de las fuentes consultadas, el investigador articula sus ideas de manera coherente); 4. **Conectar teorías y resultados** (proporciona un contexto que permite entender cómo los resultados de la investigación se relacionan con el campo del estudio). ³

2. Elabora la construcción del marco teórico del tema de su informe de investigación o TFG.

TEMA: Incidencia de Otitis Externa Difusa Aguda. Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Bata. Enero-Marzo 2024

5. Marco Teórico.

- 5.1. Definición de Otitis Externa Difusa Aguda
- 5.2. Fisiopatogenia de Otitis Externa Difusa Aguda
- 5.3. Causas de Otitis Externa Difusa Aguda
- 5.4. Síntomas de Otitis Externa Difusa Aguda
- 5.5. Diagnóstico Médico de Otitis Externa Difusa Aguda
- 5.6. Tratamiento Médico de Otitis Externa Difusa Aguda
- 5.7. Complicaciones de Otitis Externa Difusa Aguda
- 5.8. Prevención de Otitis Externa Difusa Aguda
- 5.9. Cuidados de enfermería de Otitis Externa Difusa Aguda

3. Realizar el marco teórico de su tema de informe de investigación. Máximo 5 páginas, mínimo 4 páginas. Las bibliografías de los años 2020-2024.

5. Marco Teórico.

5.1. Definición de Otitis Externa Difusa Aguda

5.1.1. Definición de otitis

La **otitis** es un término que se refiere a la **infección o inflamación del oído**. Esta condición puede afectar diferentes partes del oído. ⁴

5.1.2. Definición de otitis externa

La **otitis externa** es una **infección aguda de la piel del conducto auditivo externo**. Esta condición, comúnmente conocida como “oído del nadador”, se caracteriza por la inflamación del canal auditivo que transporta los sonidos hacia el tímpano. ⁴

5.1.3. Definición de otitis externa difusa

La **otitis externa difusa** es una **infección aguda que afecta de manera generalizada el conducto auditivo externo**. Se caracteriza por una inflamación que involucra la dermis y el tejido celular subcutáneo del canal auditivo, y puede extenderse hasta la membrana timpánica y el pabellón auricular. ⁴

5.1.4. Definición de otitis externa difusa aguda

La **otitis externa difusa aguda** es una **infección bacteriana que afecta de manera generalizada el conducto auditivo externo**. Esta condición se caracteriza por una inflamación aguda de la piel y el tejido subcutáneo del canal auditivo, que puede extenderse hasta el pabellón auricular y la membrana timpánica. Es conocida comúnmente como “oído del nadador” debido a su asociación con la exposición al agua. ⁴

La otitis externa es una inflamación que compromete la piel del conducto auditivo externo, generalmente de causa infecciosa. En un 90% de los casos tiene una etiología bacteriana y se denomina otitis externa difusa u oído del nadador.

Es una enfermedad de alta incidencia, que puede afectar hasta el 10% de la población al menos una vez en su vida. Puede comprometer a cualquier grupo etáreo, siendo más frecuente en niños entre 5 y 12 años y es 5 veces más frecuente en nadadores. La mayoría de las otitis externas ocurren en condiciones de alta humedad y temperatura. En Chile son más frecuentes en el verano o después de visitar las termas. El diagnóstico es habitualmente clínico. Otras entidades menos frecuentes son las otitis externas localizadas, otitis externa eccematosa, otitis externa micótica y otitis externa maligna. ⁴

5.2. Fisiopatogenia de Otitis Externa Difusa Aguda

En condiciones normales, el cerumen del conducto auditivo externo constituye una barrera protectora oleosa, de PH levemente ácido, además contiene lisozimas con actividad antibacteriana y antifúngica. La ruptura de los mecanismos protectores del conducto produce una alteración en la capa lipídica protectora del cerumen. El conducto se alcaliniza favoreciendo la proliferación de microorganismos comensales y patógenos. ⁴

La fisiopatogenia de la otitis externa difusa aguda implica un desequilibrio en la flora normal del conducto auditivo, lo que permite la invasión de microorganismos patógenos. La humedad excesiva, como la que se produce al nadar o al ducharse, puede alterar la barrera cutánea y facilitar la colonización bacteriana. La inflamación resultante provoca síntomas como dolor, enrojecimiento y secreción purulenta, que son manifestaciones de la respuesta inmune del cuerpo ante la infección. ⁴

5.3. Causas de Otitis Externa Difusa Aguda

La otitis externa es una infección polimicrobiana. Los agentes etiológicos más frecuentes aislados son *Staphylococcus aureus* y *Pseudomona aeruginosa*. En un estudio latinoamericano por Nogueira et al, se cultivaron 27 muestras de pacientes con otitis externa sin tratamiento antibiótico previo y con membrana timpánica integra. Se aisló *Staphylococcus aureus* en 10 casos (37%), *Pseudomonas aeruginosa* en 8 casos (29.6%), *Pseudomonas aeruginosa* y *Staphylococcus aureus* juntos en 5 casos (18.5%). Otros patógenos son principalmente candida y gram negativo distintos a *Pseudomonas* los que no causan más de 2 a 3% de todos los casos. En cuanto a los antibiogramas para las cepas aisladas, aminoglicosidos y quinolonas fueron activas para todas las bacterias aisladas, en cambio se encontró alta resistencia a penicilinas y amoxicilina/Clavulanato. ⁴

La principal causa de la otitis externa difusa aguda son las **infecciones bacterianas**, siendo **psuedomonas aeruginosas** la bacteria más frecuentemente implicada. Otras bacterias que pueden estar involucradas incluyen **Staphylococcus aureus**, **Proteus vulgaris** y **Echerichia coli**.

Además, factores predisponentes como la exposición al agua, el uso de dispositivos en los oídos y la presencia de dermatitis o alergias pueden aumentar el riesgo de desarrollar esta afección. ⁵

5.4. Síntomas de Otitis Externa Difusa Aguda

- Predomina el dolor. Se acentúa con el trago y con la manipulación.
- Tumefacción concéntrica en el conducto auditivo externo (CAE). También hay edema y eritema del CAE.
- En la enfermedad aguda hay presencia de otorrea (secreción por el conducto auditivo) verdosa. ⁵

5.5. Diagnóstico Médico de Otitis Externa Difusa Aguda

Inicio rápido (generalmente en 48 horas) de otalgia, generalmente severa, sensación de calor local y dolor al masticar. El paciente puede referir también hipoacusia o sensación de oído tapado. Puede haber prurito en los estados iniciales. El dolor suele ser desproporcionado con relación al examen físico. El antecedente de fiebre es mucho menos frecuente que en la otitis media externa.

Al examen físico puede existir exquisita sensibilidad a la presión del trago, al traccionar el pabellón auricular, o ambos. La otoscopia puede ser difícil por el dolor del paciente al contacto y estenosis por edema difuso del conducto auditivo externo. Puede haber otorrea, aunque no es un signo necesario para el diagnóstico. Suelen existir adenopatías sensibles pre o retroauriculares. La membrana timpánica en estados precoces está normal, en estados avanzados está eritematosa o deslustrada. En cuadros avanzados aparece eritema y edema del pabellón auricular y piel adyacente. La presencia de fiebre sugiere compromiso más allá del conducto. ⁶

5.6. Tratamiento Médico de Otitis Externa Difusa Aguda

Hecho el diagnóstico de otitis externa es fundamental indicar antiinflamatorios y calor local para manejo del dolor. Existe diversidad de posibilidades en base a amino glicósidos o quinolonas, que pueden asociarse a anestésicos tópicos, corticoides y soluciones acidificantes. La terapia tópica debe administrarse 3 gotas dos o tres veces al día, según su composición. Es necesario enseñar al paciente a colocar las gotas óticas en forma concreta y mantener las gotas por 2 a 3 minutos en el oído. Con antecedentes de perforación timpánica o presencia de tubos de ventilación se debe evitar el uso de gotas con amino glicósidos (neomicina, gentamicina) por su demostrada ototoxicidad. En casos de mayor edema de la pared del conducto se prescriben antibióticos orales. El tratamiento debe prolongarse por 7 a 10 días.

La derivación al otorrinolaringólogo es recomendable en todos aquellos casos en los que no se logra visualizar adecuadamente el tímpano. El especialista puede acelerar

la curación de la infección con el aseo de detritus en el conducto auditivo externo bajo visión con microscopio y, en aquellos casos de edema obstructivo del conducto, puede colocar una mecha de gasa o esponja quirúrgica por 48-72 horas para permitir la entrada del tratamiento tópico. ⁶

5.7. Complicaciones de Otitis Externa Difusa Aguda

Algunas complicaciones pueden ser el absceso subperióstico, el absceso de Bezold, la parálisis facial, la laberintitis, la meningitis, el absceso epidural, el subdural/cerebeloso, la trombosis del seno sigmoide y la hidrocefalia óptica, pudiendo ser algunas de ellas potencialmente mortales. ⁷

5.8. Prevención de Otitis Externa Difusa Aguda

Para evitar que se produzca la otitis de verano o externa, se recomienda:

- Utilizar tapones de oídos para bañarse
- Secarse bien los oídos después del contacto con el agua
- Evitar la utilización de cotonitos y pinzas en la limpieza del canal auditivo
- Evitar baños prolongados en piscinas y lagos
- Uso de gotas óticas preventivas
- Tratar condiciones de la piel
- Consultas médicas: si se presentan síntomas como picazón, dolor o secreción en el oído, es importante consultar a un médico para recibir tratamiento oportuno y evitar complicaciones. ⁷

5.9. Cuidados de enfermería de Otitis Externa Difusa Aguda

- durante todo el periodo de tratamiento el paciente debe evitar mojar el oído.
- El calor local alivia el dolor
- Recomendar al paciente usar tapones
- No exponer al niño al humo del tabaco
- Evitar que se introduzcan objetos en el oído
- Manos y juguetes limpios
- Fomentar la lactancia materna
- Llevar al día su calendario de vacunaciones
- Infecciones controladas. ⁷

4. Elaborar las referencias bibliográficas de las bibliografías revisadas. En las preguntas 1 y 3.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Anckermann,S. Cheesman, S. Marco teórico. 2ª edición. Guatemala. Editorial Mc Graw Hill interamericana. 2022. pág. 1
2. Arias, F. Proyecto de Investigación: Marco teórico. 6ª edición. Caracas. Editorial Episteme. 2023. Pág. 19
3. Sabino, C. Procesos de Investigación: Marco teórico. 1ª edición. Bogotá. Editorial lumen. 2022. Pág. 13-25
4. Martínez, J. Gómez, L. Otitis externa difusa aguda: concepto, causas y fisiopatogenia. 2ª edición. Madrid, España. Editorial Salud. 2022. Pág. 15-68
5. Martínez, J. López, R. Manejo clínico de la otitis externa difusa aguda. 1ª edición. Barcelona, España. Editorial Médica. 2023. Pág. 30-50
6. González. A. Pérez, M. Otitis externa difusa aguda: diagnóstico y tratamiento. 2ª edición. España. Editorial Médica. 2021. Pág. 45-60
7. Ramírez, T. Sánchez, L. Actualización en el tratamiento de la otitis externa difusa aguda. 3ª edición. Buenos Aires, Argentina. Editorial de Salud. 2022. Pág. 15-25